UKR Universitätsklinikum Regensburg

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie

STT-Verordnung

[redacted]

Datum der Untersuchung:	23.02.2026
Tumornachsorgekalender-Nr:	
ausgestellt am:	
Überweiser:	Praxis für Urologie -[redacted]

Primärdiagnose: (Datum)	01/2026
Primärtumor:	C61 - Bösartige Neubildung der Prostata, Diagnostiziert 23.02.2026 (Aktiv)
Histologie des Primärtumors:	Prostatakarzinom, Gleason 7b, iPSA: 15 ng/ml
TNM bei Erstdiagnose:	T1c
aktuelle Lokalisation: (z.B. Metastase/Rezidiv)	Prostata
TNM-Stadium:	cM0

THERAPIEVERLAUF: (Zeitraum, Schema + Zyklen bzw. Dosis bei Radiatio)

01/2026 ED PCA (iPSA: 15 ng/ml) durch Stanzbiopsie: 5/12 pos. Stanzen, Gleason 7b
->konventionelles Staging unauffällig
-> RT + ADT vs. OP

02/2026 Patient wünscht RT (-> ADT event. sequentiell durch Urologie)

ALLGEMEINANAMNESE: (Familienanamnese, Risikofaktoren, Vorerkrankungen z. B. Cor/Pulmo, Stoffwechsel, Kollagenosen, Operationen, usw.)

VE: VHF (nimmt Lixiana), rheumatoide Arthritis (nimmt Immunsuppressivum)

Allergien: Penicillin (?)

Allergien:	☒ ja ☐ nein	Port/PEG:	☐ ja, ☒ nein
Schrittmacher:	☐ ja ☒ nein	Betreuung:	☐ ja ☒ nein

TUMORANAMNESE/aktuelle Beschwerden:

ED durch Routinescreening, keine größeren Beschwerden

AKTUELLER STATUS:

Karnofsky-Index:	70% - Arbeitsunfähig, jedoch selbstständig im Alltag. (Karnofsky)	Größe:	172 cm	Gewicht:	83 kg

stabiler AZ, regulärer EZ

BESTRAHLUNGSVERORDNUNG:

Begründung der Strahlentherapie – Indikation: ☒ kurativ ☐ palliativ ☐ gutartig

Zielvolumen und Dosierung:	Primäre RT d. Prostata + SB-Region: ED 2 Gy bis GD 60 Gy, dann Boost bis GHD (76-) 80 Gy
Simultane Systemtherapie:	☐ nein ; ☐ ja, sequentiell event. ADT durch Urologie
Vorbestrahlung (wann/Lokalisation/Dosis):	☒ nein ; ☐ ja,

Kontakt **SozDienst** besprochen/Infoblatt ausgehändigt ☒ ja ausgebender Arzt: Abdullah Orhan

auswärtige Bildgebung: [ ] eingelesen: ☐ ja

Bestrahlungsgerät: ☐ L1 ☐ L2 ☒ L3 ☐ AL/Intrabeam

Termine:

Planungs-CT / Maske / Markierung:	02.03.2026 11:30 Uhr
Ersteinstellung:	10.03.2026 11:15 Uhr
Labor vor Chemo:	
☐ Tagesklinik:	
☐ Station:	
Sonstiges:	

Datum: 23.02.2026 10:47:42 **erstellender Arzt:** [redacted]

Datum: 24.02.2026 10:12:17 **F-/O-Arzt:** [redacted]

UKR Universitätsklinikum Regensburg

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie

CT-Anforderung

[redacted]

CT-Anordnung vom: 23.02.2026

Anordnender Arzt: [redacted]

DIAGNOSE: Primär C61 - Bösartige Neubildung der Prostata, Diagnostiziert 23.02.2026 (Aktiv)

Behandlungsindikation: Kurativ;
RT Prostata + SB-Region

LAGERUNGS- UND SCANVORGABE:
REGION:

☐ Schädel ☐ Hals ☐ Thorax ☐ Abdomen ☒ Becken ☐ 4D-Atemstudie ☐ DIBH

☐ Spezielle Anforderung Region:

☐ bei Erreichen einer GHD von Gy ☐ am:

☐ Extremitäten:

☐ Ganzkörper-CT:

☐ **bitte Arzt hinzurufen**

(Soll ein Flap aufgelegt werden, z. B. Basaliom Kopfregion, muss der Flap durch den Ambulanzarzt VOR dem Planungs-CT aufgelegt werden. Bei Basaliom Nasen-/Ohrregion bitte statt Flap Planungs-CT mit Moulage.)

Lagerung:

☐	Bauchlage	☐	Belly step
☒	Rückenlage	☐	Pro step
☒	Arme: auf Brust	☐	Knee step
☐	Maske: ☐ Netz ☐ IMRT ☐ HyperArc	☐	Schultermarker
☐	Nackenschale	☒	Blasenfüllung: voll, Enddarm: leer
☐	Wing step	☐	Anusmarkierung
☐	Knierolle	☐	Drahtmarkierung:
☒	Bluebag	☐	Vaginaltampon
☐	Flap/Moulage (siehe Anmerkung in Rot)	☐	Kopfschale
☐	Zahnschienen	☐	

Datum: 23.02.2026 10:38:26 **erstellender Arzt:** [redacted]

Datum: 24.02.2026 10:12:48 **F-/O-Arzt:** [redacted]

Die Planungs-CT ist Bestandteil der Bestrahlungsplanung und der dazugehörenden Patientenaufklärung.

UKR Universitätsklinikum Regensburg

Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie

CT-Dokumentation

[redacted]

Datum der Untersuchung: **09.03.2026**

Gewicht Patient: **83 kg**

Ganzkörper-CT: ☐ Patientendurchmesser < 30 cm

☐ Patientendurchmesser > 30 cm (Probeliegen bei Erstgespräch)

Referenzpunkt: **Tischhöhe:** 15

LAGERUNG:

☐	Bauchlage	☐	Belly step: ☐ A ☐ B ☐ C
☒	Rückenlage	☐	Pro step:
☒	Arme: auf Brust	☐	Knee step:
☐	Maske: ☐ Netz ☐ IMRT ☐ HyperArc	☐	Schultermarker:
☐	Nackenschale: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H	☒	Blasenfüllung: Voll
☐	Wing step; Ring: ☐ ja ☐ nein	☐	Anusmarkierung
☐	Knierolle	☐	Drahtmarkierung:
☒	Bluebag	☐	Vaginaltampon
☐	Flap/Moulage:	☒	Kopfschale
☐	Zahnschienen: ☐ oben ☐ unten	☐	blaue Matte
☐	Bauchpresse ☐ P1 ☐ P2 ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL Stärke:		
☐	schiefe Ebene	☐	
☐	DIBH	☐	4D-Atemstudie
☐	Name Atemkurve:		

Portrait, Lag.foto

Nach Durchführung der CT <u>verpflichtende</u> Kontrolle (DA) **kontrolliert:**

1. Wirbelsäule optisch und im Scout gerade gelagert? Keine metallischen Lagerungshilfen im Bild? ☒
2. Ref-markierung **(Bleikugeln!)** im CT-Schnitt auf einer Schicht? ☒
3. Blasen-/Rektumfüllung kontrolliert? ☒
4. KM-Reste Darm/Blase -> Arzt dazu ☐
5. Ganzer Patientenumfang wird rekonstruiert? ☒
6. Bei Kontroll-CT: Was wurde mit Bleikugeln markiert?

Datum: 09.03.2026 11:53:41 **MTRA:** [redacted]

Datum: 09.03.2026 13:04:47 **F-/O-Arzt:** [redacted]